

HEALTHCARE BRAND

ReStep

다시 걸을 수 있도록
걸음을 함께하는 헬스케어

다시 걷는 그날까지. **ReStep**과 함께합니다.

ReStep 팀 소개



김태형

Team Leader

팀장 / 총괄

10MWT 보행분석
물리치료사 임상 5년차
대학원 박사과정



조영민

TUG & Timer

TUG / 10m 시간측정

TUG 분석 · 시간측정
반도체 전자과 출신
CAD 등 다양한 툴 활용



조주연

TUG & Timer

TUG / 10m 시간측정

TUG 분석 · 시간측정
물리치료사

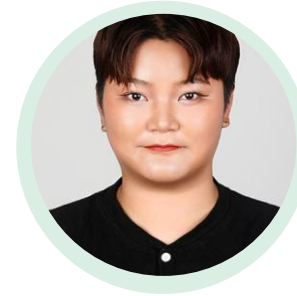


장민서

BBS Team

BBS 8~14번

균형검사 후반부 담당
물리치료사



신현주

BBS Team

BBS 1~7번

균형검사 전반부 담당
물리치료사

ReStep은 하겠습니다.

1



자동화를 통한 측정 시간 절감

AI 기반 자동 측정으로 치료사의 시간을 절약하고, 환자에게 더 집중할 수 있습니다.

2



표준화된 측정으로 근거중심 재활 환경 구축

측정 결과를 표준화하여 데이터 기반의 객관적 재활 치료 환경을 구축합니다.

3



타 도구 대비 설치·운영 비용 절감

고가의 전용 장비 없이 스마트폰만으로 측정이 가능해, 설치 비용과 유지 운영비를 대폭 절감합니다.

우린 이렇게 하겠습니다

데이터가 만드는 변화 — 측정을 넘어 표준으로

1

병원·치료사 차이 제거

동일한 평가 도구 + 동일한 측정 방식

환자의 움직임만 남는다

— 측정자 변수를 제거합니다

2

질환별 회복 궤적 분석

축적된 데이터로 패턴 발견

표준 데이터로 비교 가능

— 환자별 예후 예측이 가능해집니다

3

국가 정책 근거 제공

재활 치료의 객관적 성과 증명

치료 효과의 객관적 증거

— 국가 표준 데이터로 활용됩니다

종이차트의 숫자 하나 → **국가 표준 데이터**

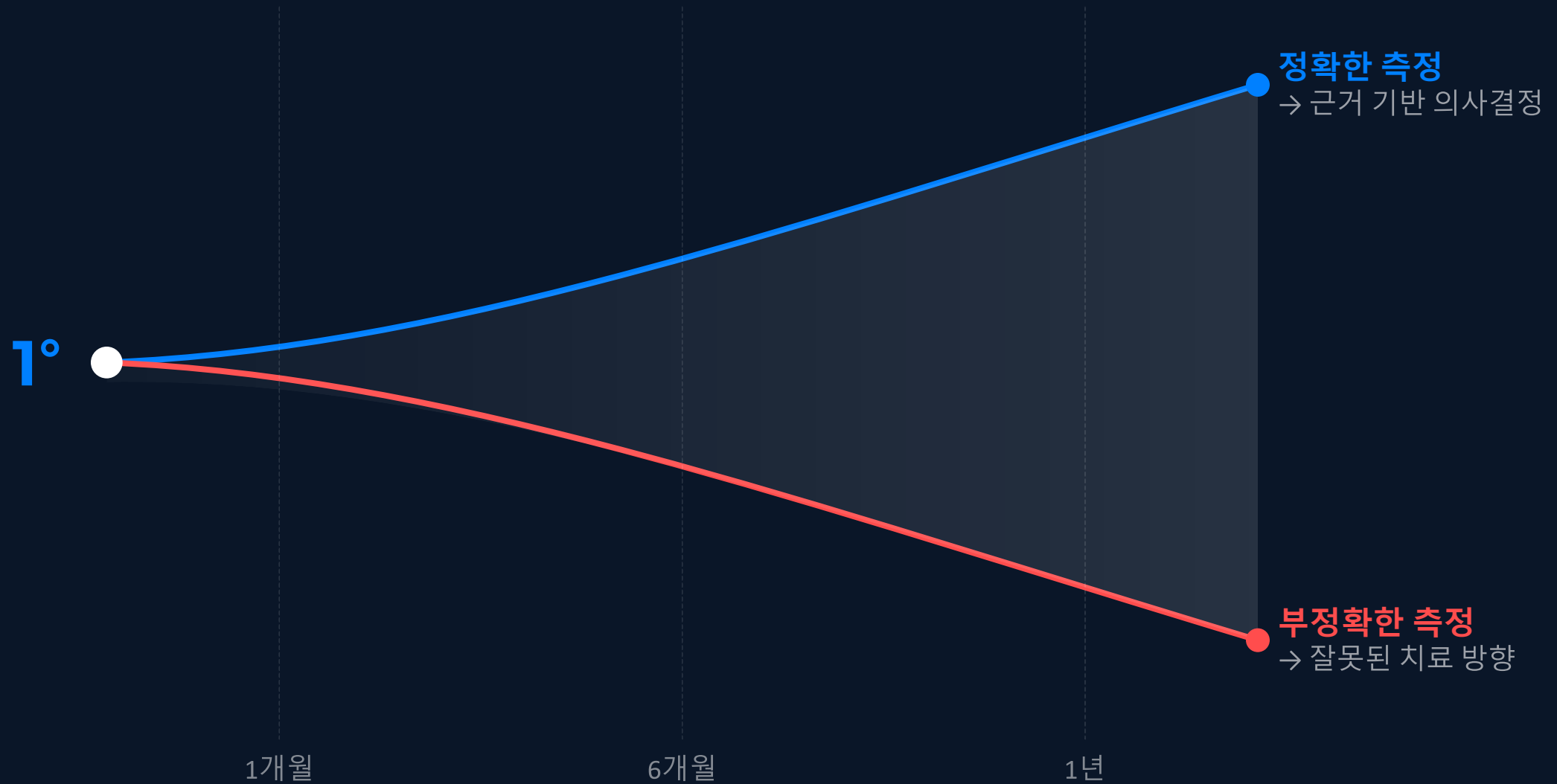
“

Garbage In, Garbage Out.

”

잘못된 데이터를 넣으면, 잘못된 결과가 나온다.

측정의 나비효과



검증된 도구의 양만으로는 충분하지 않다 — 측정의 질이 결과를 바꾼다

연간 **10만 건** 이상의 데이터를 어떻게 하시겠습니까?

정확한 기준, 질 좋은 데이터 — 사람이 놓치는 것까지 기록해야 합니다.

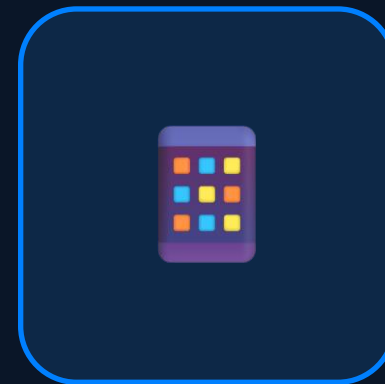
기존 방식



- ✗ 장비 1대 수천만 원
- ✗ 스탑워치 — 치료사가 직접 들고 측정
- ✗ 종이·펜 — 수기 기록으로 인한 정확성 감소
- ✗ 사람이 놓치는 데이터는 기록 불가

VS

ReStep



스마트폰

- ✓ 기존 평가 그대로 (BBS·TUG·10MWT)
- ✓ 정량 데이터로 업그레이드
- ✓ 장소 제약 없음 — 어디서든 측정
- ✓ 추가 장비·비용 불필요

어디서 시간이 줄어드는가?

각 평가의 소요 시간은 세 단계로 나뉩니다

①

준비 / 설명

환자에게 검사 방법을
설명하고 준비시키는 시간

여전히 필요

②

환자 수행

환자가 실제로 걷거나
동작을 수행하는 시간

줄일 수 없음

③

측정 / 기록

스톱워치 조작, 수기 기록,
EMR 입력, 점수 계산

ReStep이 자동화!

ReStep의 자동화 영역

스톱워치 조작 불필요 · 결과 자동 계산 · EMR 입력 자동화 · 반복 시행 시 즉시 측정 · 점수 자동 산출

평가 도구별 시간 절감 – 얼마나 ?

현재 소요 시간 vs ReStep 적용 후 — 현실적 절감 추정

10MWT

10미터 보행검사

현재

≤ 5분



ReStep

~2분

절감: 약 3분

절감 근거

- 스톱워치 조작 불필요
- 결과 자동 계산·기록
- 반복 시행 시 즉시 측정

TUG

Timed Up and Go

현재

≤ 5분



ReStep

~2분

절감: 약 3분

절감 근거

- 5단계 타이밍 자동화
- EMR 입력 불필요
- Phase별 분석 자동 생성

BBS

Berg Balance Scale

현재

15~20분



ReStep

10~15분

절감: 약 5분

절감 근거

- 시간 측정 항목 자동화
- 점수 자동 산출·기록
- 치료사 관찰 채점은 유지

합계: 현재 21~30분 → ReStep 적용 후 14~19분 = 환자당 7~11분 절감

하루가 쌓이면, 시간이 됩니다

환자당 약 10분 절감이 누적되면

~10분

/ 환자

3개 평가 합산
1회 절감 시간

1~2시간

/ 일

하루 8~12명 기준
치료사 1인당

20~40시간

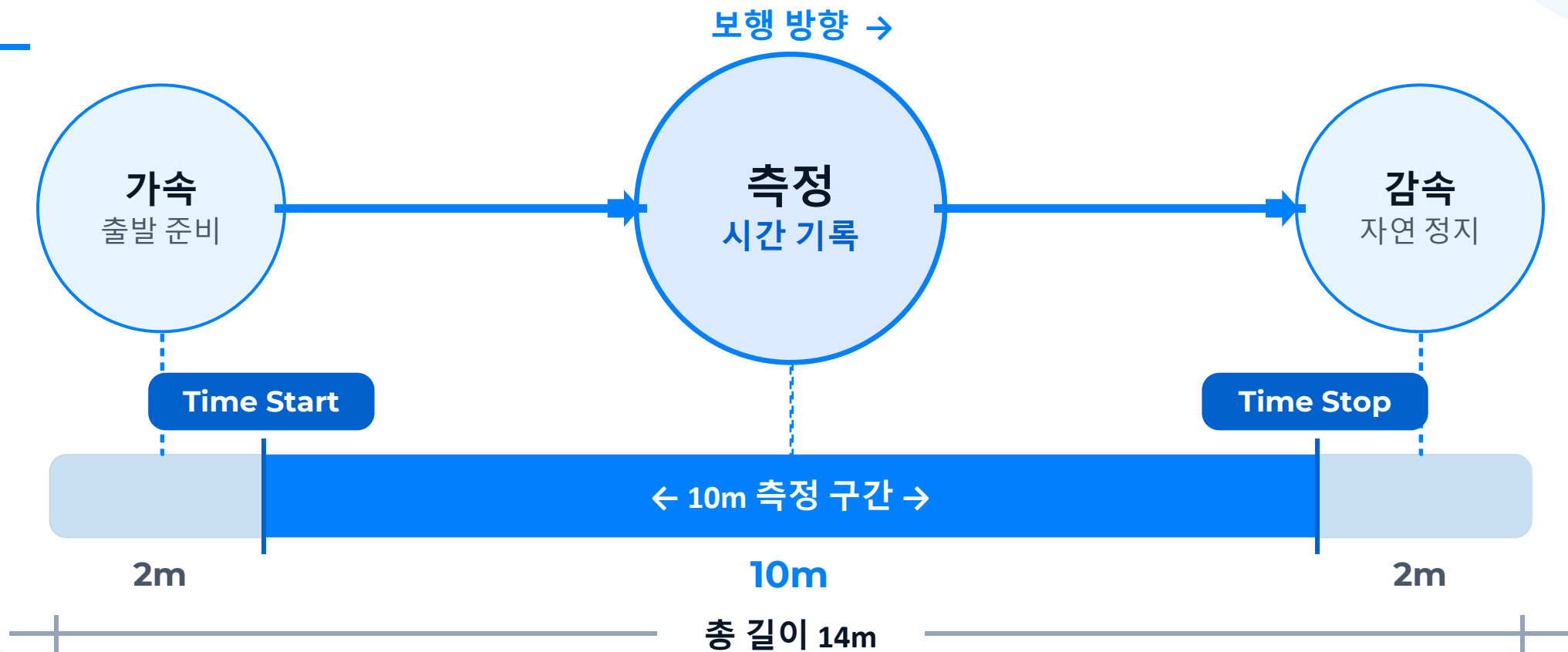
/ 월

월 20일 근무 기준
추가 치료 가능 시간

절감된 시간의 가치

- ✓ 치료사가 더 많은 환자를 볼 수 있음 (접근성 향상)
- ✓ 수기 기록 오류 제거 → 데이터 신뢰도 향상
- ✓ 반복 평가 부담 감소 → 경과 추적 용이

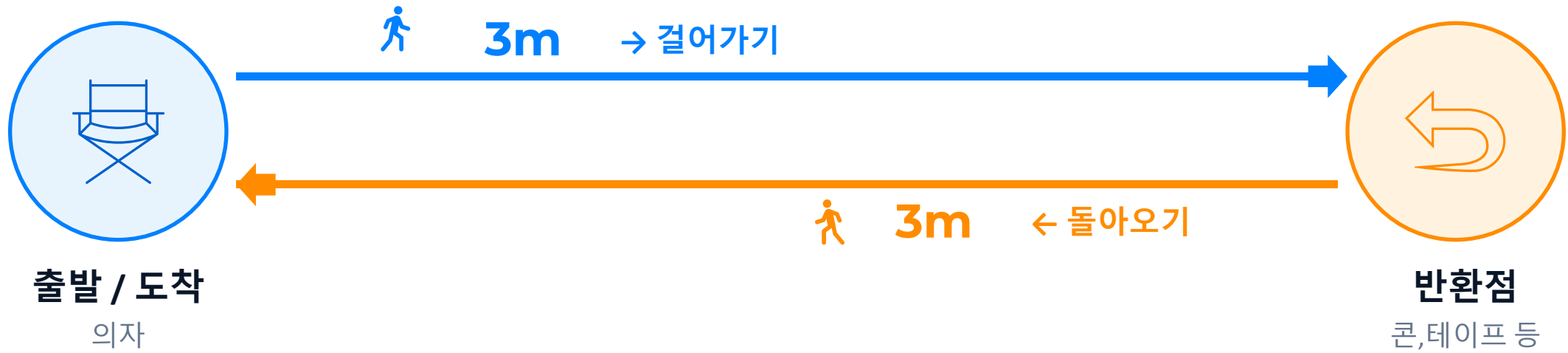
10미터 걷기 검사



다시 걷는 그날까지. **ReStep**과 함께합니다.

TUG 검사 방법

Timed Up and Go — 의자에서 일어나 3m 왕복 후 착석, 전체 시간 측정



① 의자에서 일어나기 → ② 3m 걸어가기 → ③ 반환 후 돌아오기 → ④ 의자에 앉기



전체 소요 시간 측정

* 평소 신발 및 보행 보조기구 사용 가능 | 의자 높이 45~46cm 권장

BBS 검사 방법

Berg Balance Scale — 14개 항목, 5점 척도(0~4점), 총 56점 만점

정적 균형 · 자세 유지 (10항목)

1 앉은 자세에서 일어서기

2 도움 없이 서기

3 도움 없이 앉기

4 선 자세에서 앉기

5 이동하기

6 눈감고 서기

7 발 모으고 서기

8 팔 뻗어 앞으로 내밀기

9 바닥 물건 집어 올리기

10 뒤돌아보기

동적 균형 · 이동 (4항목)

11 360도 돌기

12 발 교대로 올리기

13 일렬로 서기 (탠덤)

14 한 발로 서기

14개 항목 · 5점 척도

총 56점

각 항목 0~4점으로 채점

BBS, 정말 객관적인가?

평가자마다 다르게 해석되는 모호한 기준들

감독 (Supervision)

신체 접촉 없이 환자의 안전을 지켜보는 단계

과도한 흔들림?

"과도한" 흔들림의 기준은 누가 정하나요?

구두 지시가 필요한 순간?

말로 주의를 줘야 할 타이밍은 주관적입니다

근접 대기의 거리?

"팔이 닿는 거리" — 사람마다 다릅니다

도움 (Assistance)

검사자의 신체적 접촉이 필요한 상태

접촉 보호 보조

만지고 있지만 힘은 가하지 않는 상태

→ '최소한의 도움'과 동일 기준 채점

물리적 지지 (Min~Max)

직접 힘을 보태어 도와주는 상태

최소·중등도·최대 보조 → 0~1점

"힘의 비율"은 어떻게 측정하나요?

같은 환자, 다른 점수 — 평가자에 따라 결과가 달라집니다

검증된 도구, 검증되지 않은 측정

세계에서 가장 많이 연구된 재활 평가 — 아직도 스톱워치와 종이차트로 측정 중

7,000+

BBS

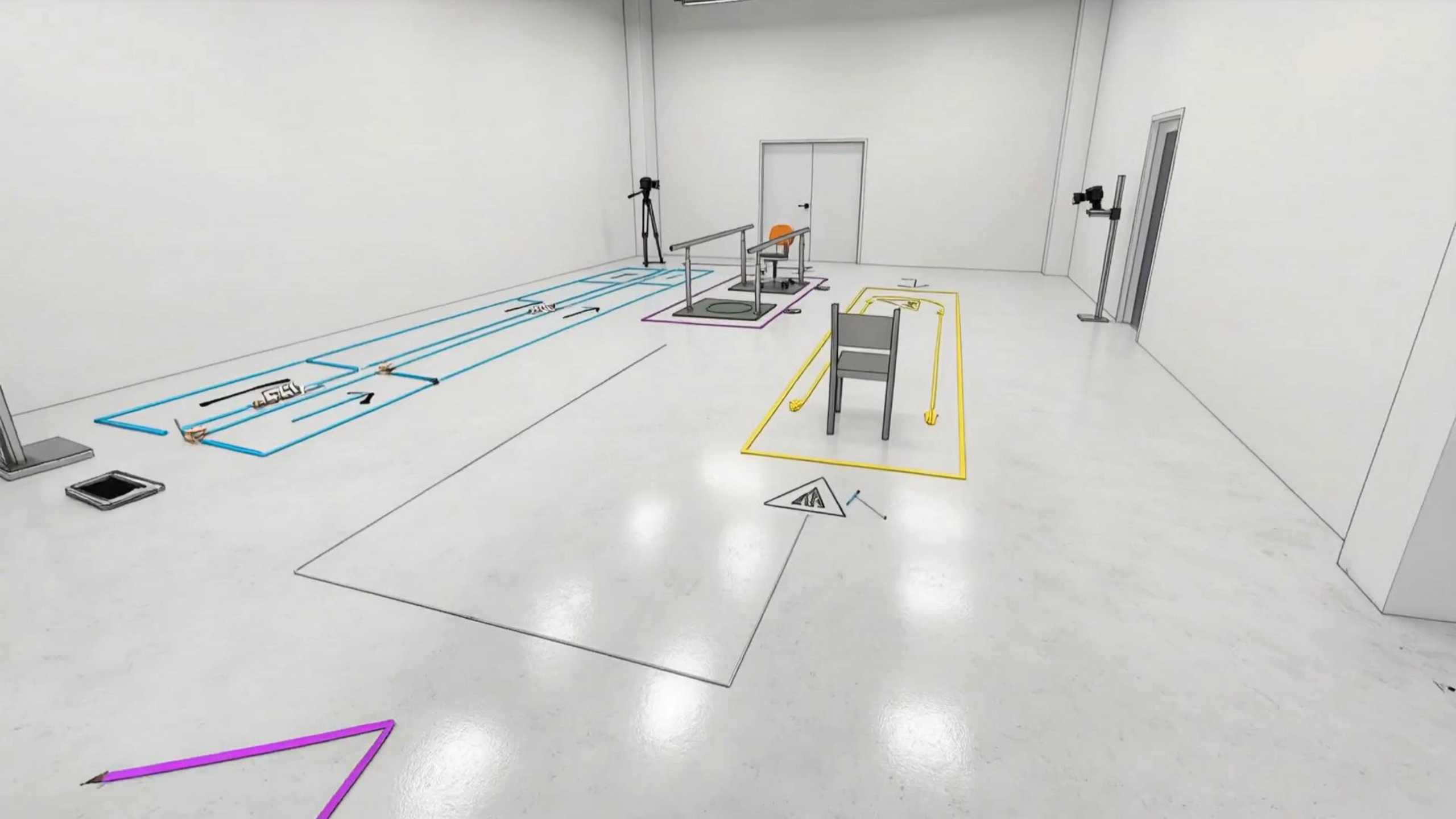
5,000+

TUG

3,000+

10MWT

* PubMed 등재 연구 건수 기준



검사별 최소감지변화 (MDC)

이 수치 이하의 변화는 호전인지 오차인지 구분할 수 없다

BBS

Berg Balance Scale

6.6점 / 56점

MDC (최소감지변화)

56점 만점 중 6.6점 이하의
변화는 의미 있는 변화로
판별할 수 없다

*Downs et al., 2013
J Physiotherapy*

TUG

Timed Up and Go

3.2초

MDC (최소감지변화)

3.2초 미만의 시간 변화는
실제 개선인지 측정 오차인지
판별이 불가능하다

*Alghadir et al., 2018
BMC Neurology*

10MWT

10m Walk Test

0.36 m/s

MDC (최소감지변화)

보행 속도 0.36m/s 미만의
차이는 임상적으로
유의미하지 않다

*Tilson et al., 2010
Neurorehabil Neural Repair*

MDC = 이 변화량 이상이어야 **"진짜 좋아졌다"**고 말할 수 있다

ReStep은 MDC를 줄인다

$$\text{MDC} = 1.96 \times \sqrt{2} \times \text{SEM}$$

SEM을 줄이면 → MDC가 줄어든다 → 더 작은 변화도 감지

현재 문제

BBS

치료사 간 채점 차이

82.2%가 ≤3점 차이
→ SEM ↑ → MDC 6.6점

TUG

스톱워치 오차 0.2~0.3초
→ SEM 1.16초 → MDC 3.2초

ReStep 접근

01

측정자 변수 제거

센서 자동 측정
주관·반응시간 → 0

02

SEM 감소

측정 표준오차
구조적으로 줄어듦

03

MDC 감소

공식에 의해
MDC 자동 감소

기대 효과

BBS

MDC ↓
3점 변화도 유의미

TUG

MDC ↓
1초 변화도 감지

10MWT

보폭·대칭성·가속도
→ 새로운 민감 지표

펜

기록지



기존 vs ReStep

같은 환자, 같은 회복 — 감지 결과는 다르다

기존 (스톱워치 + 수기 채점)

BBS

MDC 6.6점

"5점 좋아졌어요"

→ 오차 범위 — 유의미하지 않음

TUG

MDC 3.2초

"2초 빨라졌어요"

→ 오차 범위 — 유의미하지 않음

10MWT

MDC 0.36m/s

"0.2m/s 빨라졌어요"

→ 오차 범위 — 유의미하지 않음

ReStep (센서 자동 측정)

BBS

MDC ↓ 예상

"3점 변화도 유의미"

→ 센서 채점 → 주관 오차 제거

TUG

MDC ↓ 예상

"1초 변화도 감지 가능"

→ 자동 타이밍 → 반응시간 0

10MWT

새로운 지표

보폭·대칭성·가속도 분석

→ 속도 MDC에 의존하지 않음

MDC가 줄어들면 → 환자의 작은 회복도 데이터로 증명된다

TUG

12.3초

10MWT

8.7초

BBS

45점

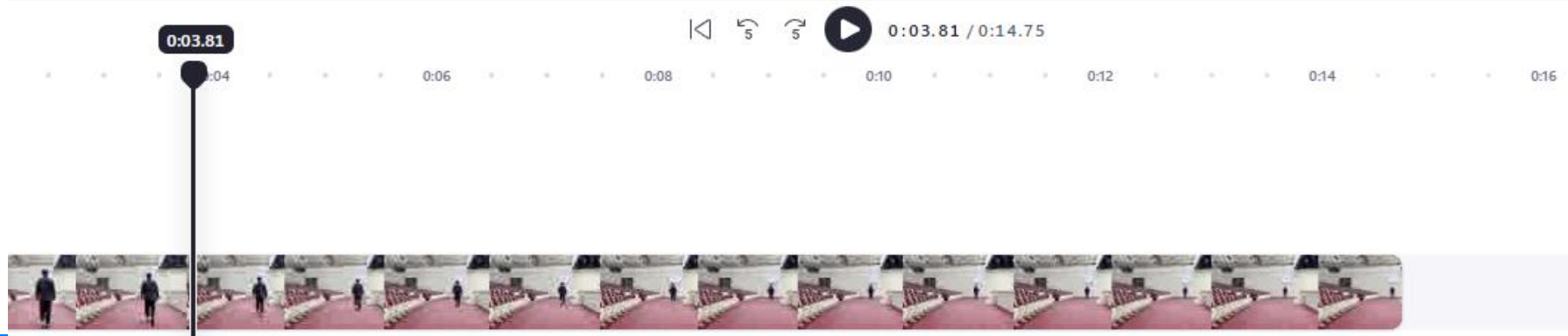
남는 건 이 숫자 뿐

나머지 모든 움직임 정보는 사라진다

분석표



분석표



분석표



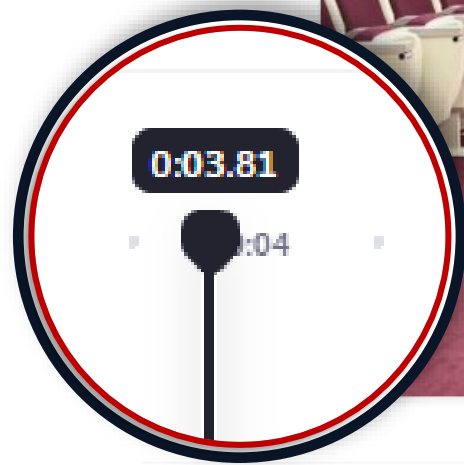
0:03.81



0:03.81 / 0:14.75



분석표

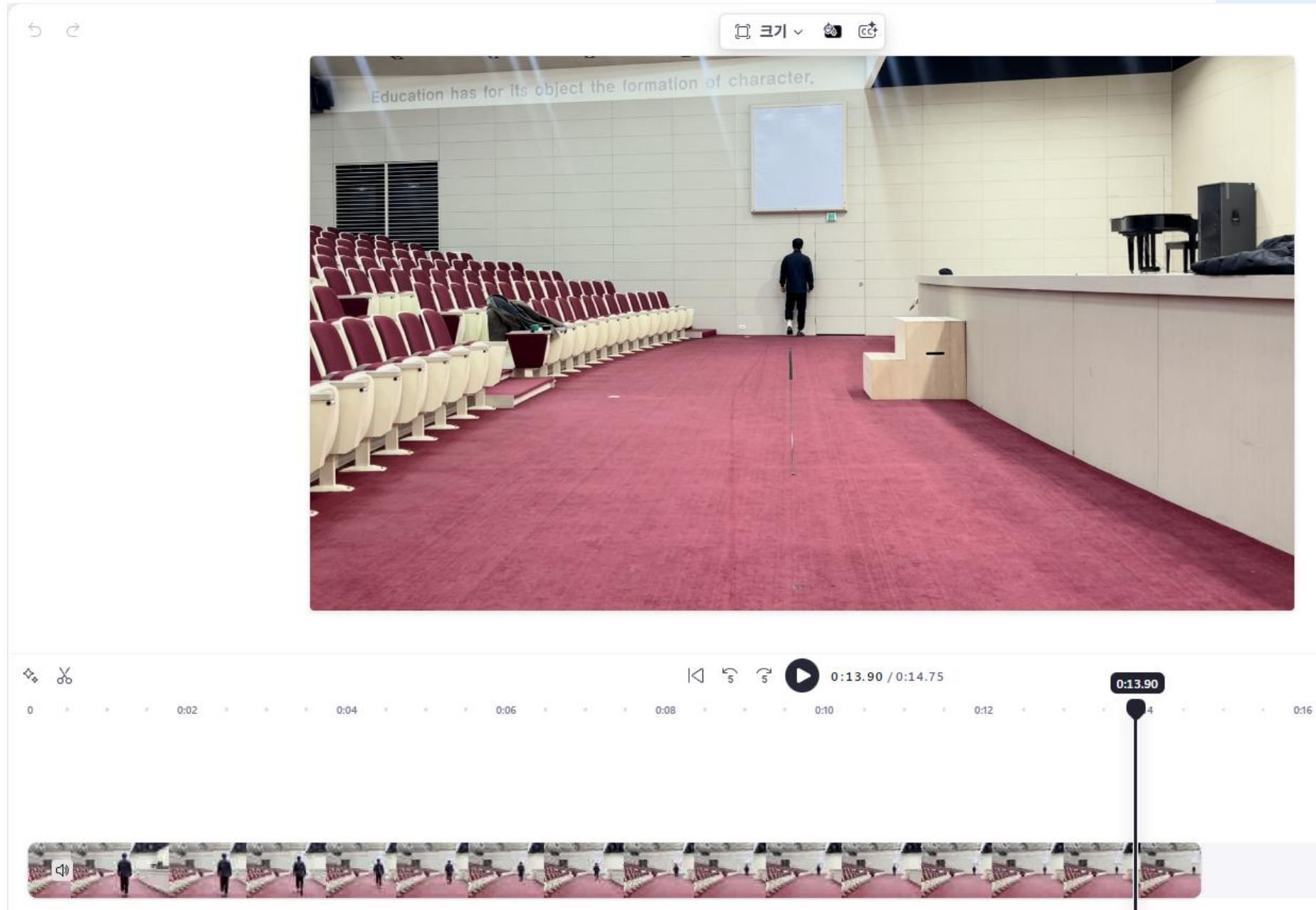


0:03.81

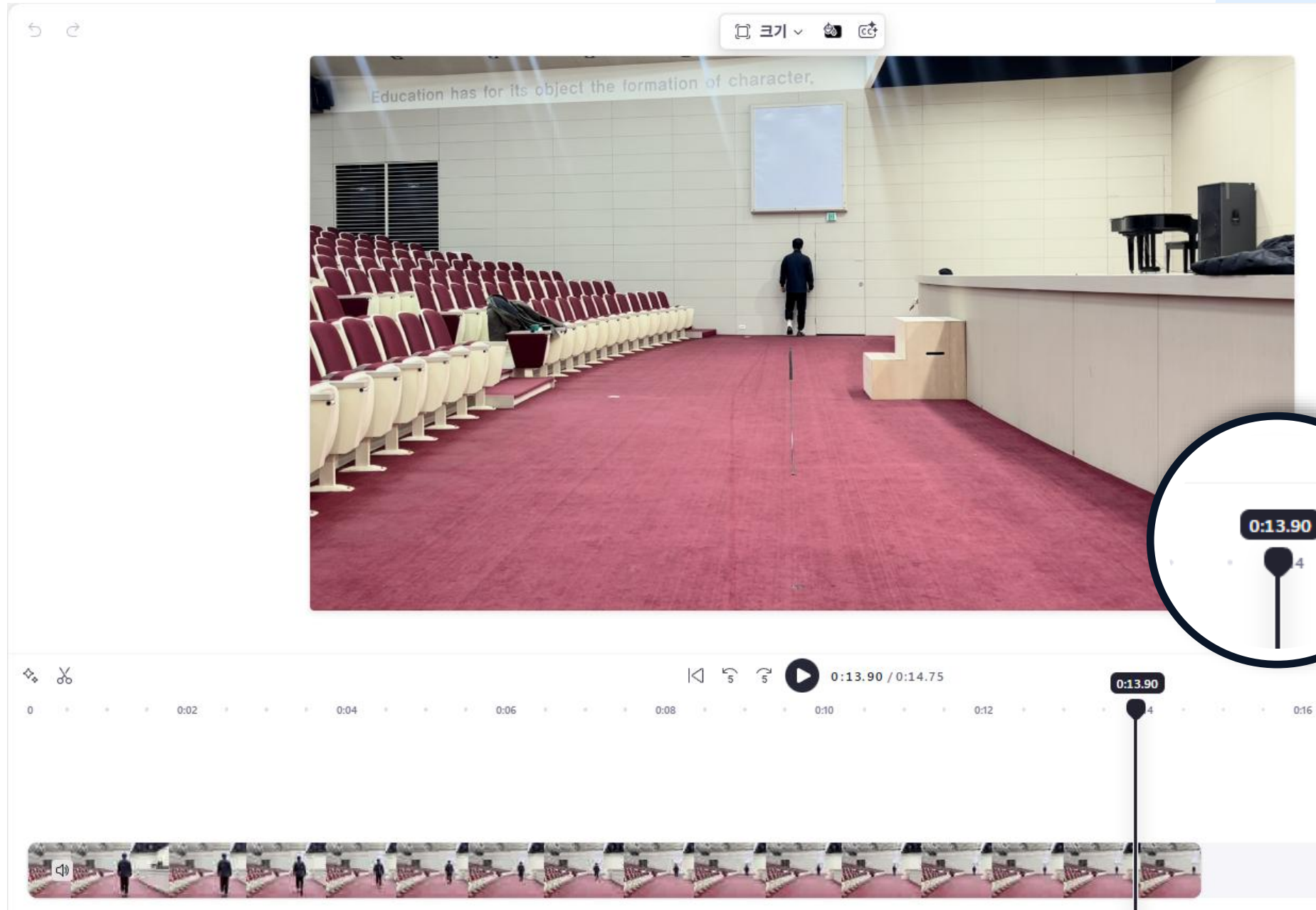
0:03.81 / 0:14.75



분석표



분석표



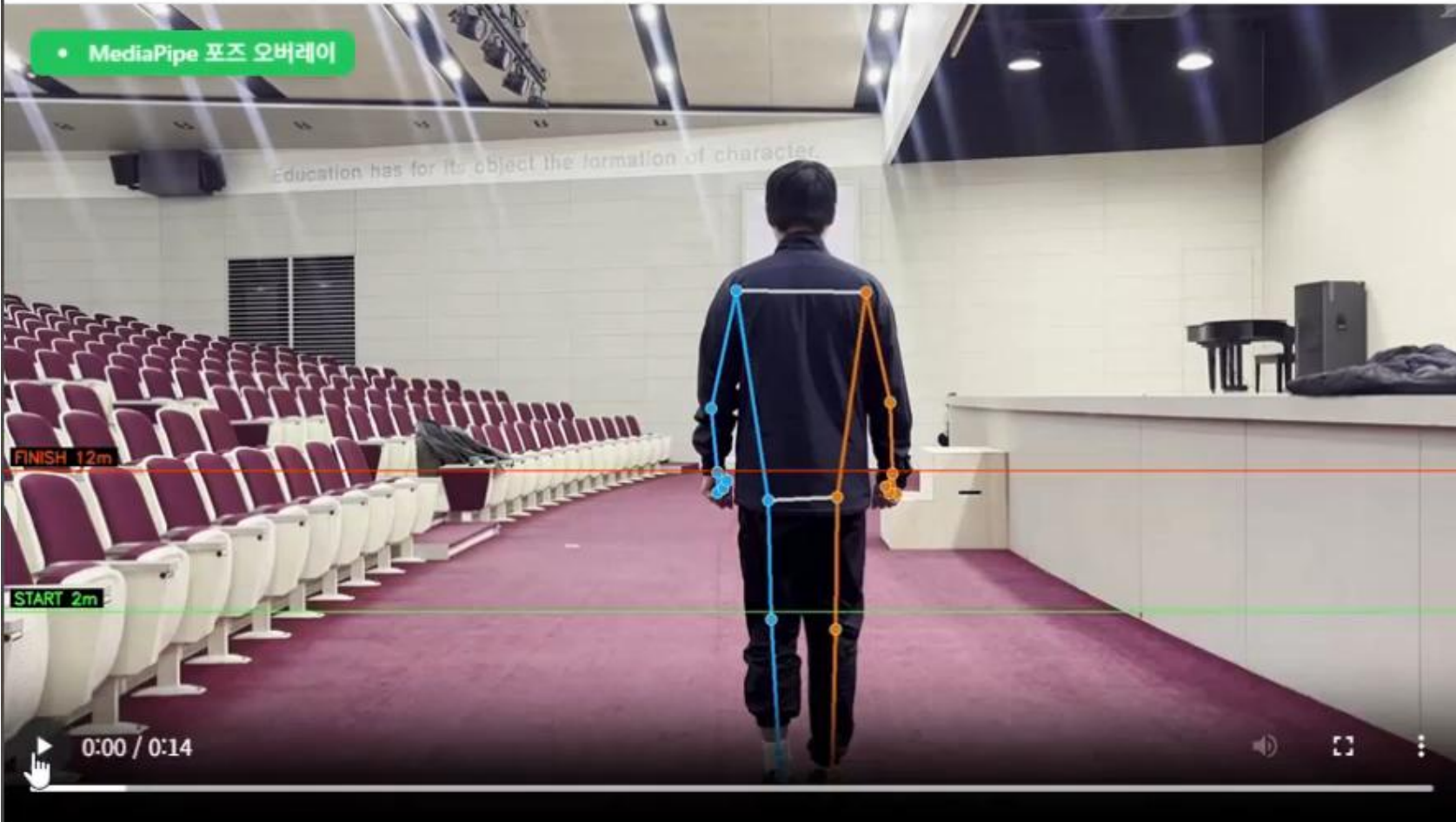
분석표

검사 동영상

2026. 2. 22. · 10.43초 · 0.96m/s

👤 포즈 ×

MediaPipe 포즈 오버레이



Education has for its object the formation of character.

FINISH 12m

START 2m

0:00 / 0:14

MediaPipe 포즈 분석 영상

검사 분석 시 녹화된 관절 포인트와 스켈레톤 연결선이 표시됩니다.

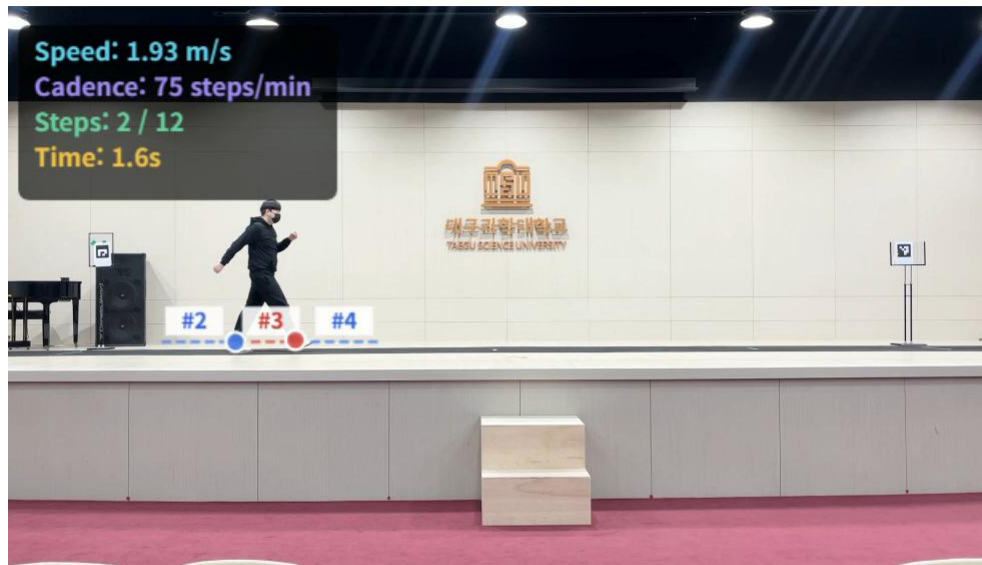
파일 크기: 24.05 MB

↓ 다운로드

영상 분석

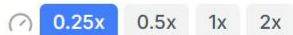
보행 분석 영상

접기



1.6s

7.0s



Speed
1.93 m/s

Cadence
75 spm

Steps
2

Time
1.6s

핵심 지표

1.77
보행 속도 (m/s)

7.00
소요 시간 (초)

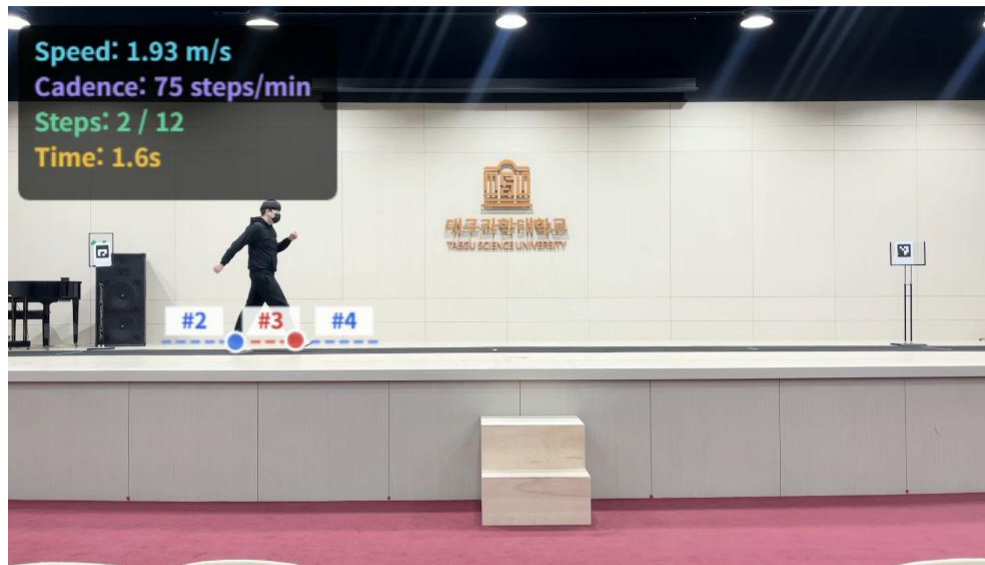
116
케이던스 (steps/min)

12
총 걸음 수

영상 분석

보행 분석 영상

접기



1.6s

7.0s



0.25x 0.5x 1x 2x

Speed
1.93 m/s

Cadence
75 spm

Steps
2

Time
1.6s

핵심 지표

1.77
보행 속도 (m/s)

7.00
소요 시간 (초)

116
케이던스 (steps/min)

12
총 걸음 수

영상 분석

▶ 전체 보행 구간 (6.5s ~ 13.6s) ×

보행 속도 ↑ 0%

1.89

Fast Walker

2.0 m/s

2.1s

▶ 구간 재생

⌂ 슬로우 모션 (0.25x)

0.1x 0.25x 0.5x 1x

영상 분석

개별 Step 분석

각 스텝의 보폭(반대발→이 발)을 개별 확인

#	발	보폭 (cm)	시간 (s)	
2	L	102.2	0.516	▶
3	R	106.0	0.533	▶
4	L	102.5	0.523	▶
5	R	108.7	0.515	▶
6	L	103.3	0.532	▶
7	R	105.3	0.480	▶
8	L	109.0	0.567	▶
9	R	104.0	0.467	▶
10	L	100.4	0.546	▶
11	R	105.5	0.489	▶
12	L	98.6	0.512	▶

L 평균: 102.7cm
범위: 99~109cm (6회)

R 평균: 105.9cm
범위: 104~109cm (5회)

▶ Step #5 (R) (8.6s ~ 9.4s) X

▶ 구간 재생

⌂ 슬로우 모션 (0.25x)

0.1x0.25x0.5x1x

분석표

거리 변수				
항목	측정값	정상범위	판정	코멘트
좌측 보폭 (L Step) ▶	102.7 cm	-	-	SI%로 대칭성 평가
우측 보폭 (R Step) ▶	105.9 cm	-	-	SI%로 대칭성 평가
좌측 활보장 (L Stride) ▶	211.5 cm	-	-	SI%로 대칭성 평가
우측 활보장 (R Stride) ▶	206.7 cm	-	-	SI%로 대칭성 평가
비율 변수				
항목	측정값	정상범위	판정	코멘트
입각기 비율 (Stance) ▶	55.7 %	58~62%	↓ 2.3	입각기 감소: 빠른 보행 또는 측정 오차 확인 필요
유각기 비율 (Swing) ▶	44.3 %	38~42%	↑ 2.3	유각기 증가: 빠른 보행 시 정상적 변화

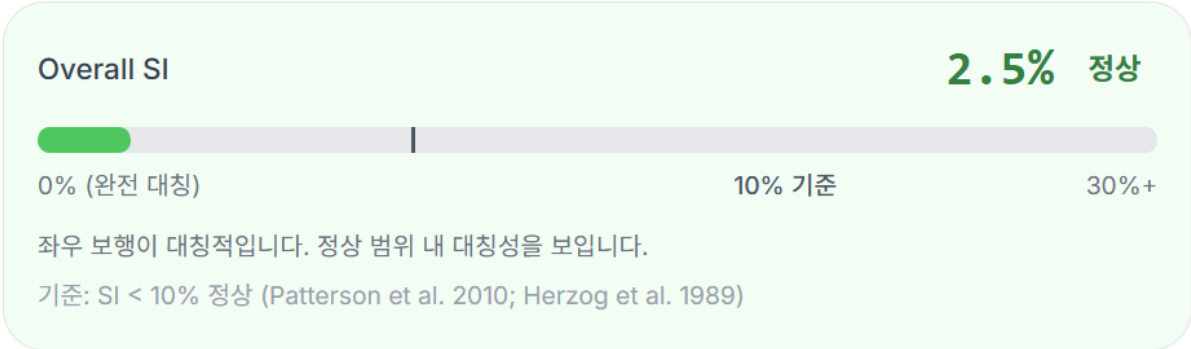
거리 대칭성

전체 보행 구간의 L/R 평균값 기반

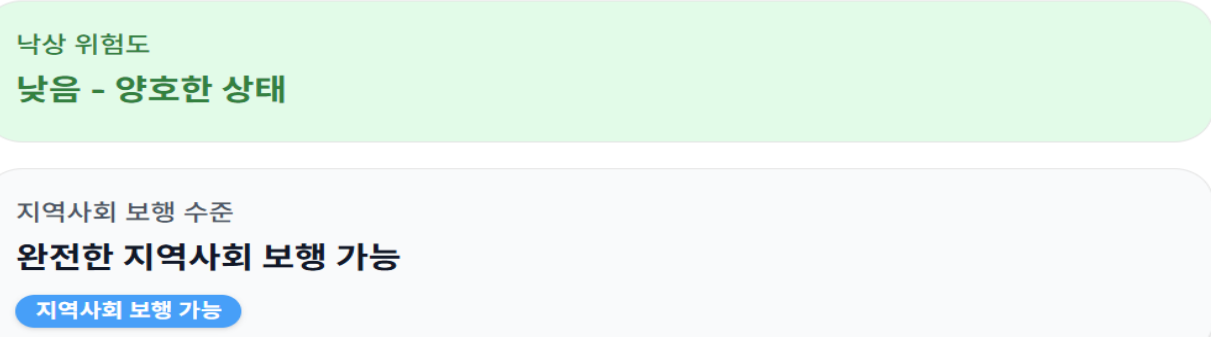
항목	L	R	SI%	
보폭 Step (cm)	103	106	3	▶▶
활보장 Stride (cm)	212	207	2	▶▶

분석표 - 종합 대칭성 지수

📈 종합 대칭성 지수

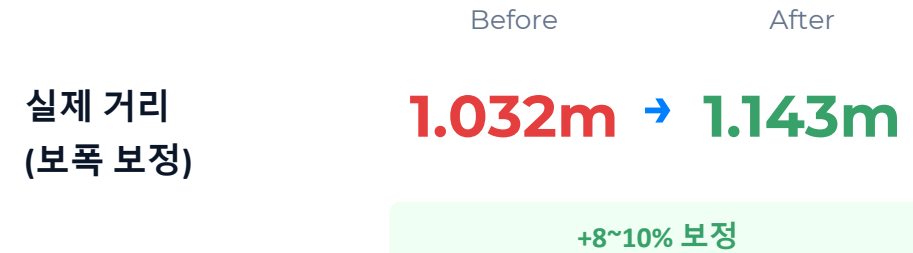
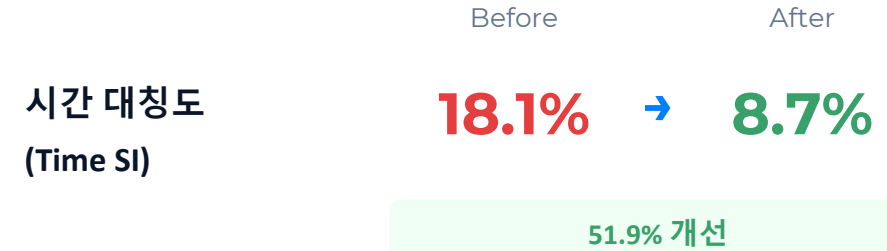
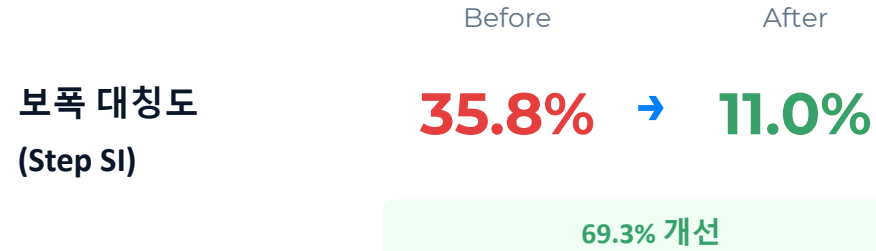


📈 임상 해석



통합 개선 성과

C+D+K 패스 적용 전후 보행 지표 비교



SI(대칭성 지수) 10% 미만 달성

- STEP 1 YOLO + MediaPipe 듀얼 포즈 추정으로 Heel 좌표 확보
- |
- STEP 2 3단계 Heel Strike 감지로 오탐지 원천 차단
- |
- STEP 3 Homography 원근 보정으로 실제 거리(m) 복원
- |
- STEP 4 C-D-K 패스 최적화로 비대칭 오차 극적 감소

스마트폰 하나로, 임상 수준의 보행 분석을 실현합니다.

영상 분석 - TUG 검사

10m 보행검사
영상 보행 분석
2026. 2. 22. · 12.71초 · 0.00m/s

순차 재생: 측면 순차재생

• 측면 포즈 오버레이 (순차재생)

무릎 90°
골반 100°

보행 영상 변수 (자)

검사 기록 12

12 TUG 20

11 TUG 20

10 TUG 20

9 TUG 20

8 TUG 20

0:00 / 0:14

MediaPipe 포즈 분석 영상
정면 영상: 어깨와 골반의 기울기 분석에 적합합니다. 좌/우 균형을 확인하세요.

무릎/골반 관절 각도 (측면 영상)
무릎 90° 골반 100°



영상 분석

TUG 검사 결과

총 소요 시간

12.7 초

양호

TUG 평가 기준

<10초: 정상 10-20초: 양호 20-30초: 주의 >30초: 위험

단계별 소요 시간

클릭하여 캡처 보기



● 일어서기: 2.3초 ● 걸기 (나감): 4.3초 ● 돌아서기: 1.5초
● 걸기 (돌아옴): 4.1초 ● 앉기: 0.5초

기립/착석 분석

↑ 기립

2.3초

느림

👉 손으로 짚고 일어남

↓ 착석

0.5초

느림 (안정적)

👉 손으로 짚고 앉음

운동 반응 분석

🕒 반응 시간

4.19초

첫 움직임까지 소요 시간

👣 첫 걸음 시간

0.15초

기립 완료 후 첫 발걸음

분석표

기울기 분석 (정면 영상)

어깨 기울기

평균 **-0.1°**

최대 21° | 균형

골반 기울기

평균 **+0.2°**

최대 23.4° | 균형

자세 불균형에 주의가 필요합니다.

↔ 체중이동 분석 (정면 영상)

좌우 흔들림

0.7%

최대 편향

5.0%

진동 주파수

1.1Hz

기립 시 체중이동

L R 균형

좌우 이동 궤적 (평균 중심)

진폭 (Amplitude): $\pm 4.3\%$



약간의 체중이동 불균형이 관찰됩니다.

기립/착석 분석

↑ 기립

2.3초

느림

☝ 손으로 짚고 일어남

↓ 착석

0.5초

느림 (안정적)

☝ 손으로 짚고 있음

운동 반응 분석

⚡ 반응 시간

4.19초

첫 움직임까지 소요 시간

↗ 첫 걸음 시간

0.15초

기립 완료 후 첫 발걸음

기울기 분석 (정면 영상)

어깨 기울기

평균 **-0.1°**

최대 21° | 균형

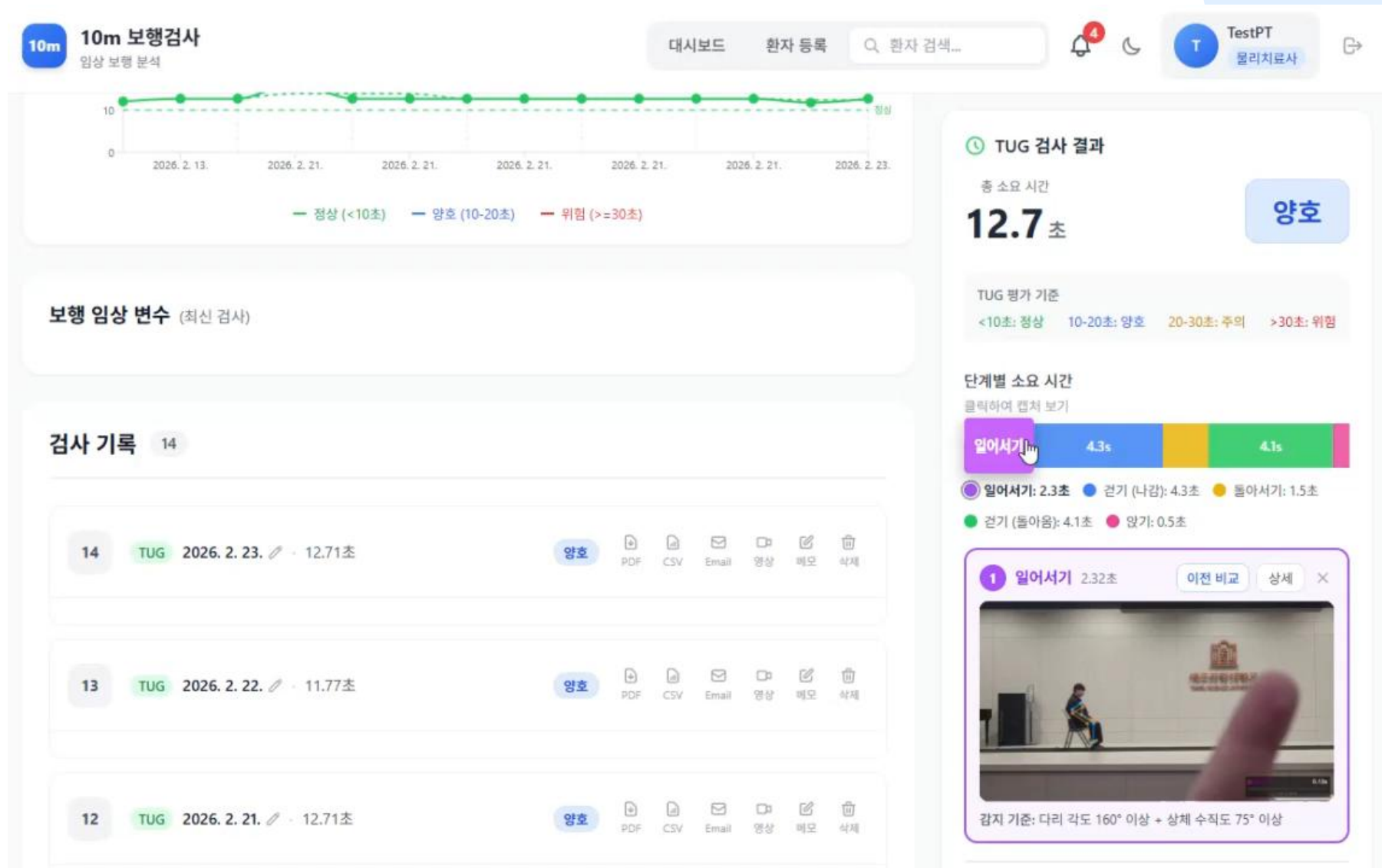
골반 기울기

평균 **+0.2°**

최대 23.4° | 균형

자세 불균형에 주의가 필요합니다.

영상 분석



v10

실시간 분석 + 3D 포즈 + 검증 결과

WebSocket 실시간 분석과 3D 시각화, 그리고 4세트 완벽 검증

실시간 TUG 분석

MediaPipe.js → WebSocket

→ 서버 분석 → Phase 콜백

→ 실시간 전환 감지

3D 포즈 데이터

매 3프레임 월드 좌표 추출

Phase 어노테이션 태깅

React Three Fiber 시각화

스톱워치 오버레이

Phase별 색상 타이머 UI

진행 바 + 총 시간 표시

Phase별 클립/캡처 생성

검증 결과 — 4세트 듀얼 영상 분석

TUG 1

신뢰도 100

12.05s

0.50 m/s

양호

TUG 2

신뢰도 100

12.71s

0.47 m/s

양호

TUG 3

신뢰도 100

16.29s

0.37 m/s

양호

TUG 4

신뢰도 100

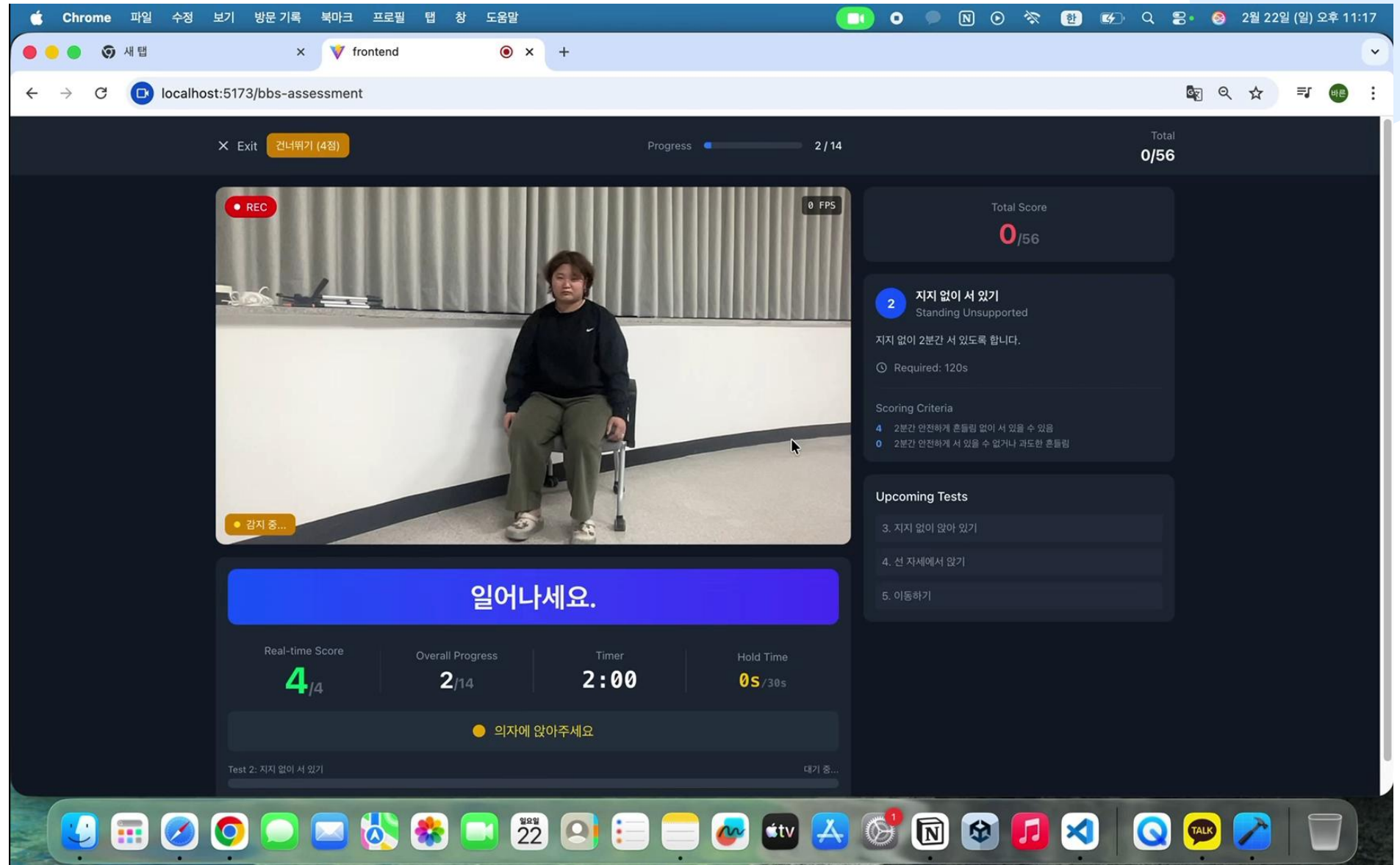
19.01s

0.32 m/s

양호

4/4 세트 분석 성공 | 전체 신뢰도 100/100 | TUG 12.05~19.01초 (모두 10~20초 양호 범위) | 5단계 구간 감지 + 정면 기울기 정상 작동

영상 분석



영상 분석

frontend

localhost:5174/bbs-assessment

Exit

건너뛰기 (4점)

Progress

3 / 14

Total

0/56

REC

0 FPS

1명 감지

환자 분석 중

등받이 감지 (Z값)

-0.061

✓ 정상

정상 범위: -0.20 ~ -0.05

그대로 유지해주세요

Real-time Score

0/4

Overall Progress

3/14

Timer

1:48

Hold Time

14s/30s

Total Score

0/56

3 지지 없이 앉아 있기

Sitting Unsupported

발을 바닥에 평평하게 놓고 팔을 접은 채로 앉아 있도록 합니다.

Required: 120s

측면 촬영 권장

측면 권장: 등받이 기대기 여부를 정확히 감지

Scoring Criteria

4 2분간 안전하고 흔들림 없이 앉아 있을 수 있음

0 2분간 안전하게 앉아 있을 수 없거나 과도한 흔들림

Upcoming Tests

4. 선 자세에서 앉기

5. 이동하기

6. 눈 감고 서 있기

영상 분석

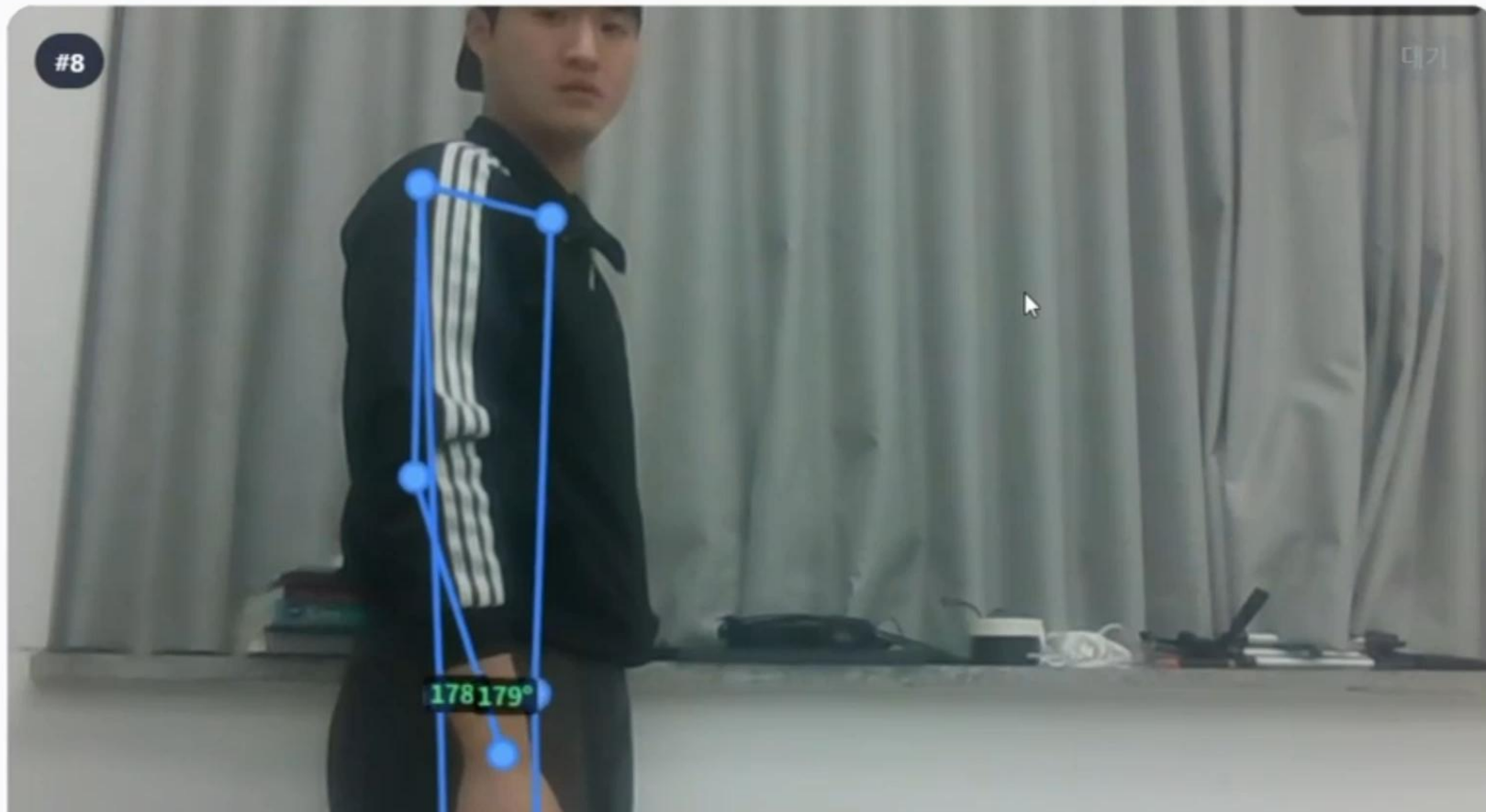
8

팔 뻗어 앞으로 내밀기 측면

선 자세에서 팔을 90도로 뻗어 앞으로 최대한 내밀기

#8

대기



14개 검사 항목과 채점 체계

각 항목 0~4점, 총 56점 만점 — 현재 MVP는 이진 채점 (4점 or 0점)

1	앉은 자세에서 일어서기	동작	8	팔 뻗어 앞으로 내밀기	동작
2	지지 없이 서 있기 (2분)	타이머	9	바닥에서 물건 집어 올리기	수동
3	지지 없이 앉아 있기 (2분)	타이머	10	뒤돌아보기 (좌/우)	타이머
4	선 자세에서 앉기	동작	11	360도 회전하기	타이머
5	이동하기	타이머	12	발판 위에 발 교대로 올리기	수동
6	눈 감고 서 있기 (10초)	타이머+수동	13	한 발 앞에 다른 발 두고 서기	타이머
7	두 발 모으고 서 있기 (1분)	타이머	14	한 발로 서 있기 (10초)	타이머

채점 방식

0 ~ 56점

14항목 × 4점 = 총점

MVP: 이진 채점 (4 or 0)

낙상 위험도

0~20점 → 높음

21~40점 → 중간

41~56점 → 낮음

감지 방식: **동작 감지** — AI 자동 판별 | **타이머** — 시간+자세 자동 측정 | **타이머+수동** — 자동+치료사 확인 | **수동** — 치료사 직접 채점

시간 절감 효과와 향후 계획

기존 수기 측정

15~20분

수기 채점 + 점수 계산 + 서류 작성



ReStep 자동화

10~15분

자동 채점 + 자동 기록 + 리포트 즉시

절감 효과

~5분

/ 환자 1명당

하루 20명 → ~100분 절약

향후 계획

Phase 1

5단계 채점 확장

이진(4/0점) → 5단계(0~4점) 세분화

Phase 2

수동 항목 완전 자동화

12/14개 → 14/14개 자동 감지

Phase 3

ADL 연동 종합 리포트

낙상위험도 + 시계열 추이 시각화

Phase 4

질환별 맞춤 프로토콜

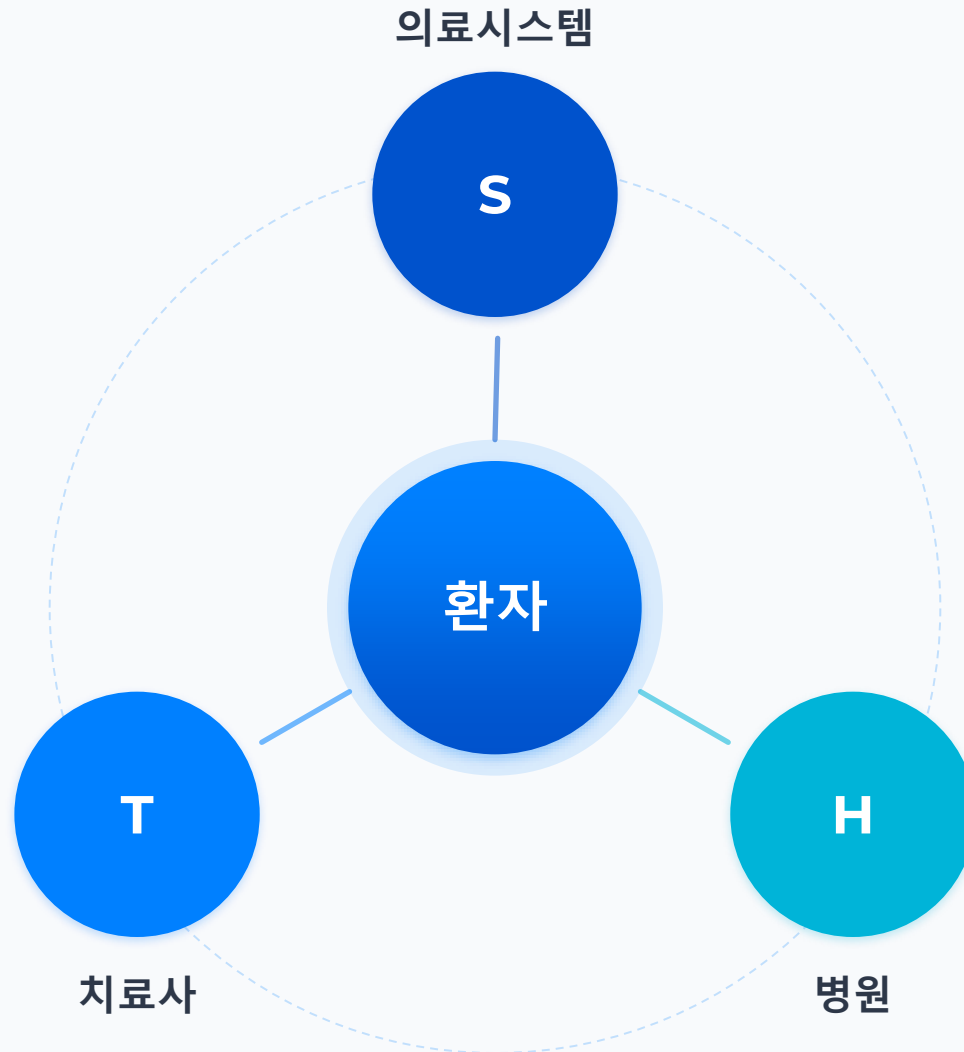
뇌졸중 · 파킨슨 등 맞춤 임계값

ReStep0이 만드는 변화

환자 · 병원 · 의료시스템에 기여하는 ReStep의 방향

ReStep 시스템

환자 중심의 통합 의료 연결 플랫폼



ReStep이 기여하는 세 가지 축

측정에서 시작해, 표준으로 확장합니다

1

환자

나의 회복을 눈으로 확인

수치화된 보행 데이터로
회복 과정을 직접 확인

동기 부여

객관적 변화가
재활 의지를 높여줍니다

맞춤 치료

데이터 기반으로
개인별 최적 치료 가능

2

병원 · 치료사

측정 시간 단축

스마트폰으로 빠르고
정확한 평가 수행

객관적 근거 확보

치료 효과를
수치로 증명합니다

병원 간 비교 가능

동일 기준 데이터로
기관 간 벤치마크

3

의료시스템

국가 표준 데이터

재활 분야 빅데이터
인프라 구축

정책 근거 제공

근거 기반 재활 정책
수립 지원

재활 격차 해소

지역·기관 간
의료 격차 축소

로드맵

측정 도구에서 국가 재활 데이터 플랫폼으로

Phase 1

2026

Phase 2

2027

Phase 3

2028~

앱 고도화 & 임상 검증

10MWT·TUG·BBS 앱 정식 출시
재활병원 파일럿 도입
임상 데이터 수집 시작

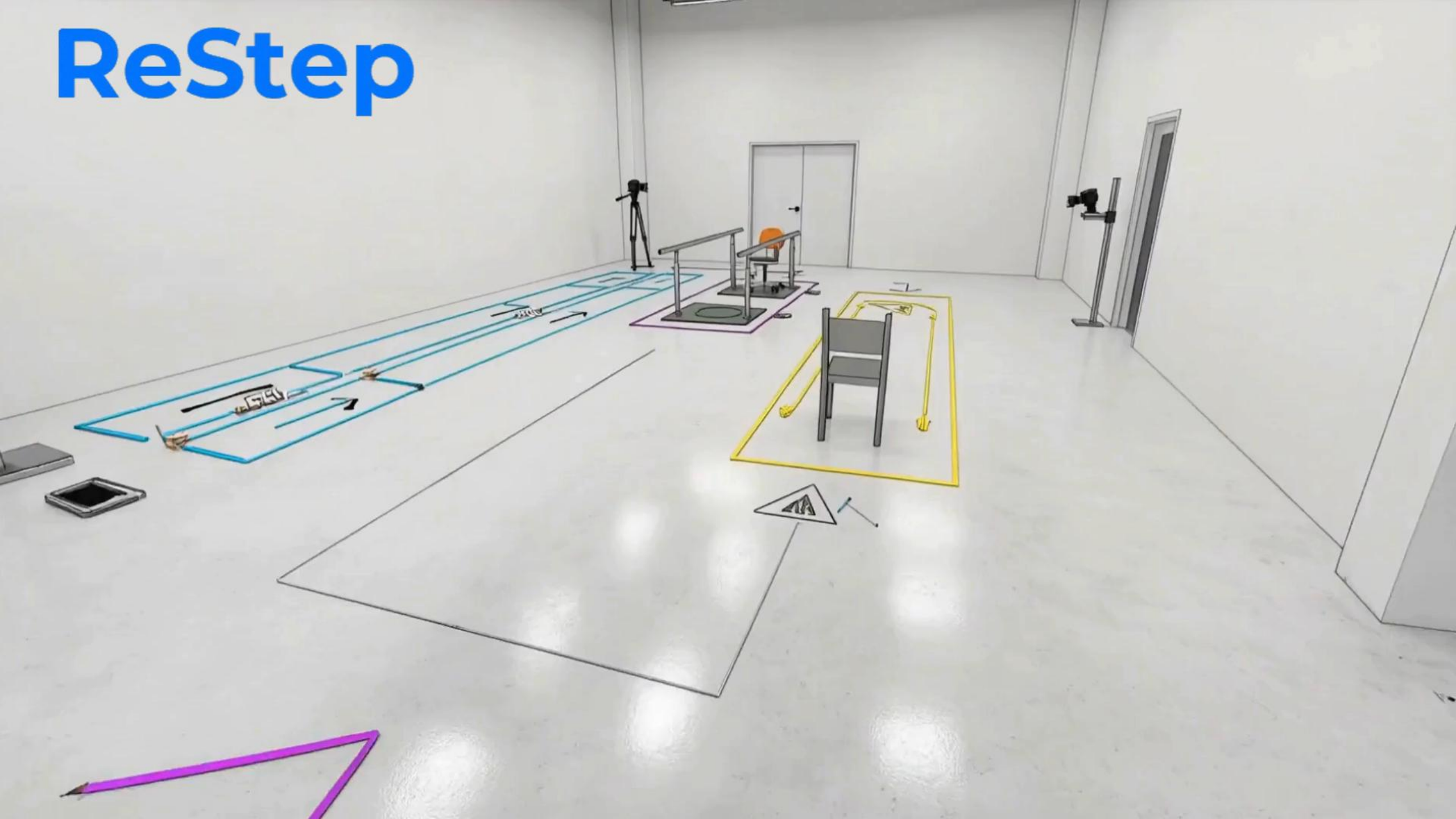
병원 확산 & 데이터 축적

전국 재활병원 확산
질환별 회복 궤적 분석
AI 예후 예측 모델 개발

국가 표준 & 플랫폼 확장

국가 재활 표준 데이터 구축
보험·정책 근거 자료 제공
아시아 시장 확장

ReStep



ReStep

다시 걷는 그날까지. ReStep과 함께합니다.



검증된 도구

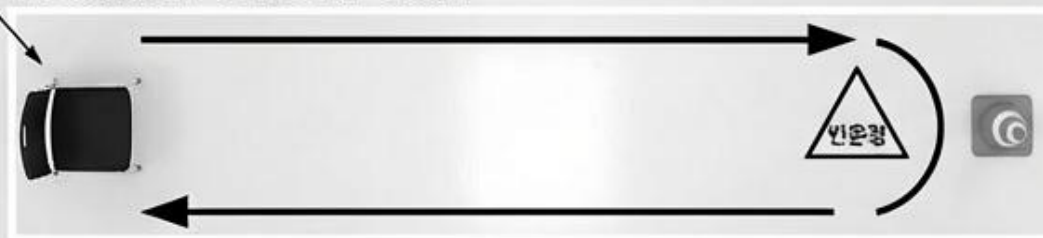


검증되지 않은 측정



TUG MEASUREMENT
CAMERA POSITION

TUG INSPECTION ZONE



TUG MEASUREMENT
CAMERA POSITION

INSPECTION
MEASUREMENT
CAMERA POSITION



OUR GOAL

ReStep이 만드는 변화

모든 이해관계자에게 실질적인 가치를 제공합니다

HOSPITAL



병원

- **접근성 향상**
치료사가 더 많은 환자를 볼 수 있음
- **데이터 신뢰도 향상**
수기 기록 오류 제거로 정확한 데이터 확보
- **경과 추적 용이**
반복 평가 부담 감소로 효율적 모니터링

THERAPIST



치료사

- **근거 기반 의사결정**
감이 아닌 데이터로 치료 방향을 정확히 설정
- **치료 효율성 극대화**
정확한 측정으로 불필요한 시행착오를 줄임
- **전문성 객관적 입증**
치료 전후 변화를 데이터로 명확히 보여줌

SYSTEM



의료시스템

- **표준화된 측정 프로토콜**
기관 간 비교 가능한 재활 데이터 체계 구축
- **의료 자원 최적화**
데이터 기반 배분으로 비용 효율성 향상
- **근거 중심 의료 문화**
측정의 질이 의료 시스템 전체를 업그레이드